

PAUSE AR | |

Nouveautés de la semaine du 3 octobre 2026

2 nouveautés cette semaine, dont 1 susceptible de changer votre pratique.

ANESTHÉSIE-RÉANIMATION PÉDIATRIQUE Essai randomisé · **PRESSURE****Permissive Blood Pressure Targets in Pediatric Critical Care: The PRESSURE Randomized Clinical Trial****JAMA** · 28 septembre 2026 · Essai randomisé pragmatique, 1 900 enfants, 23 réanimations pédiatriques

On ne sait pas quelle cible de pression artérielle moyenne viser chez l'enfant de réanimation sous ventilation invasive, traité par vasopresseurs pour une hypotension. Cet essai a comparé une cible permissive aux soins habituels, où le médecin en charge fixait lui-même son objectif de pression ; la stratégie permissive visait une pression artérielle moyenne supérieure au cinquième percentile pour l'âge. Par rapport aux soins habituels, elle a réduit de **37,5 %** la dose totale médiane de vasopresseurs, exprimée en équivalent noradrénaline, sans différence significative sur le critère principal, qui associait la mortalité et la durée de ventilation invasive à 30 jours. Sur les sept critères secondaires, seule la durée de séjour en réanimation des survivants était plus courte ; la mortalité à la sortie de réanimation, le recours à l'épuration extrarénale et les événements indésirables n'ont pas différé.

En pratique : chez l'enfant ventilé et hypotendu, viser une pression artérielle moyenne supérieure au cinquième percentile pour l'âge a réduit d'un peu plus d'un tiers la dose de vasopresseurs. Le critère principal, qui associait mortalité et durée de ventilation invasive à 30 jours, n'a pas différé significativement, pas plus que le recours à l'épuration extrarénale ou les événements indésirables. L'économie de vasopresseurs est donc établie, l'innocuité ne l'est pas : aucun retentissement n'a été détecté dans un essai de cette taille, ce qui n'est pas la même chose qu'une absence de retentissement. C'est à ce titre un argument pour ne pas relever la cible par précaution. L'essai ne dit pas pour autant jusqu'où descendre : l'écart de pression réellement obtenu entre les deux stratégies est resté de trois millimètres de mercure.

[Article original](#)**ANESTHÉSIE PÉRIOPÉRATOIRE** Méta-analyse**Intraoperative blood pressure targeting in noncardiac surgery: a Bayesian random-effects meta-analysis of randomized trials****Anesthesiology** · 28 septembre 2026 · Méta-analyse bayésienne de 15 essais randomisés

En chirurgie majeure non cardiaque, on ne sait pas si protocoliser la cible de pression artérielle peropératoire apporte un bénéfice supplémentaire par rapport aux soins habituels d'aujourd'hui. Cette méta-analyse a réuni quinze essais randomisés comparant une telle stratégie protocolisée aux soins habituels ou à une cible plus basse ; les données ont été analysées dans un cadre bayésien à effets aléatoires. Sur la mortalité, qui était le critère principal, l'estimation reste centrée sur l'absence d'effet. C'est sur l'insuffisance rénale aiguë que les estimations sont les plus favorables, mais elles restent compatibles avec l'absence de bénéfice cliniquement important et se déplacent dès qu'un seul essai est retiré de l'analyse.

En pratique : en chirurgie majeure non cardiaque, ces quinze essais réunis ne montrent pas que protocoliser la cible de pression artérielle améliore la survie ou réduit la lésion myocardique par rapport aux soins habituels. L'insuffisance rénale aiguë est le seul critère dont l'estimation aille dans le sens d'un bénéfice, mais elle n'atteint pas la significativité et se déplace dès qu'un essai est retiré de l'analyse. Ces résultats n'autorisent pas pour autant à négliger la pression artérielle peropératoire ; ils invitent seulement à ne pas attendre d'un protocole chiffré un bénéfice qu'il n'a pas démontré.

[Article original](#)

Tableau de bord complet — toutes les sorties, recherche FR/EN, fiches de lecture : pausear.fr

Fiches rédigées à l'aide de l'IA — résumés à valider par le lecteur avant toute application clinique, se reporter aux articles originaux.